



1^{er} CONGRÈS DE BIOLOGIE MÉDICALE DE SÉTIF



La pensée bayésienne en biologie clinique : vers un changement de paradigme dans l'interprétation des résultats

A. ADJISSI, F. BELLOUT, H. BOUKHAROUBA, M. ABDOUN, S. LAOUAMRI

Service d'épidémiologie et médecine préventive, CHU de Sétif. Université Ferhat Abbas.

1 INDICATEURS INTRINSÈQUES



Probabilité pré-test :
estimée par l'épidémiologie
locale, les signes cliniques
et les facteurs de risque
du patient.



Un résultat de test
n'est pas une vérité
absolue, mais un flux
d'informations qui
modifie une probabilité
initiale.



Le contexte clinique
est indispensable à
l'interprétation.

2 L'EFFET DE LA PRÉVALENCE

Probabilité post-test =
Probabilité pré-test ×
Rapport de vraisemblance (LR)

$LR+ = \text{Sensibilité} / (1 - \text{Spécificité})$

$LR- = (1 - \text{Sensibilité}) / \text{Spécificité}$



Les VPP/VPN varient
avec la prévalence.
Le LR est indépendant
de la prévalence.

CAS CLINIQUE

- Patient de 45 ans,
douleur thoracique
- Probabilité pré-test d'IDM : **30 %**
- Troponine ultrasensible :
 $LR+ = 12$
- Probabilité post-test : **84 %**

Mettre en évidence :



3 OUTILS DÉCISIONNELS

Nomogramme de Fagan :



Pré-test



LR



Post-test



$LR+ > 10$:
excellent pour confirmer



$LR- < 0,1$:
excellent pour exclure



Le biologiste ne doit plus
être un simple livreur de
résultats, mais un expert
en stratégie diagnostique
qui contextualise
le résultat.



Un test diagnostique ne s'interprète jamais isolément.



Lecture recommandée :
probabilité pré-test →
rapport de vraisemblance →
probabilité post-test.

CHU
— DE SÉTIF —



Sétif 1 University - Ferhat ABBAS